

CHECKLIST 10 POIN VERIFIKASI PRA-SUBMISI DRAFT SKRIPSI KEDOKTERAN

Quality Assurance Gate Mandiri Sebelum Bimbingan dan Ujian Semhas — NASKAH.FK

[] 01. Sinkronisasi Besaran Sampel (N)

Jumlah sampel pada Bab 3 (metodologi), Bab 4 (tabel karakteristik), dan Bab 5 (pembahasan) wajib konsisten secara utuh tanpa ada perbedaan angka yang tidak dijelaskan.

[] 02. Pelaporan Nilai P Eksak

Nilai signifikansi wajib ditulis secara eksak (contoh: $P = 0,028$), bukan $P < 0,05$. Apabila output piranti lunak statistik menunjukkan 0,000, cantumkan sebagai $P < 0,001$.

[] 03. Interval Kepercayaan 95% (95% CI)

Seluruh estimasi titik berupa Odds Ratio (OR), Relative Risk (RR), atau perbedaan rerata wajib disertai rentang 95% CI (contoh: OR = 2,45; 95% CI 1,20–4,80).

[] 04. Keseragaman Format Sitasi

Format rujukan pustaka wajib konsisten (Vancouver berurutan numerik atau APA alfabetis) mulai dari Bab 1 hingga Daftar Pustaka.

[] 05. Keterangan Singkatan pada Tabel

Seluruh akronim medis pada tabel (seperti Hb, SGOT, GDS, HT) wajib memiliki catatan kaki penjelasan di bawah tabel terkait.

[] 06. Uji Prasyarat dan Normalitas

Penerapan uji parametrik (seperti Independent T-test atau One-Way ANOVA) wajib disertai dokumentasi uji normalitas (Shapiro-Wilk untuk $n < 50$ atau Kolmogorov-Smirnov untuk $n \geq 50$).

[] 07. Konsistensi Benang Merah

Rumusan masalah pada Bab 1, tabel penyajian hasil pada Bab 4, dan butir simpulan pada Bab 5 wajib memiliki struktur dan urutan substansi yang identik.

[] 08. Pembahasan Pola 3-Tahap

Paragraf pembahasan pada Bab 5 tidak sekadar mengulang angka hasil uji, melainkan menguraikan: Temuan Inti -> Komparasi Literatur -> Mekanisme Patofisiologi.

[] 09. Uraian Keterbatasan Penelitian

Bab 5 wajib mencantumkan 2–3 keterbatasan metodologis nyata (seperti potensi bias recall atau desain observasional yang tidak membuktikan kausalitas).

[] 10. Tata Tulis Nomenklatur Medis Latin

Seluruh nama taksonomi mikroorganisme atau istilah anatomis wajib dicetak miring (contoh: *Staphylococcus aureus*, *in vitro*, *postpartum*).